REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Coagulopatias e PTI

Hemostasia, PTI, doença de von Willebrand, hemofilias, TEV e antitrombóticos em uma página

MAIS COBRADO

- **1º Padrão do sangramento** localiza o defeito
- **2º TTPa isolado** + teste de mistura
- **3º PTI**: trata-se o sangramento
- **4º Hemofilia**: dose de fator e profilaxia

1 Onde está o defeito

olhe o sangramento antes do exame

	Plaquetas ou FvW (primária)	Fatores (secundária)
Onde	Pele e mucosas: petéquias, epistaxe, gengivorragia, **menorragia**	Planos profundos: **hemartrose**, hematoma muscular
Quando	Imediato após trauma	Muitas vezes **tardio** (horas depois)
Exemplos	PTI, DvW 1 e 2, AAS	Hemofilias A e B, DvW tipo 3

TP	TTPa	Pense em
Normal	Longo	Hemofilias (VIII, IX, XI), DvW com FVIII baixo, heparina, anticoagulante lúpico
Longo	Normal	Deficiência de FVII, **início da varfarina** (FVII tem a menor meia-vida)
Longo	Longo	Vitamina K, hepatopatia, CIVD, via comum (X, V, II)
Normal	Normal	Hemostasia primária: PTI, AAS/AINE, trombocitopatias

Teste de mistura (1:1 com plasma normal): **corrige = falta fator** (hemofilia) · **não corrige = inibidor** (anti-FVIII, anticoagulante lúpico). Deficiência de FXII alonga o TTPa e não sangra.

2 Trombocitopenia imune (PTI)

plaquetas < 100.000 isoladas · exclusão

Criança: pico 2–6 anos, pós-viral, autolimitada (80–85% remitem em 12 meses). **Adulto:** crônica, mulheres. Recém-diagnosticada < 3 meses · persistente 3–12 · crônica ≥ 12. Exame físico normal fora o sangramento (sem visceromegalia, linfonodos ou dor óssea).

Mielograma só se atípico: visceromegalia, outras citopenias, falha do tratamento, > 60 anos. **Alarme:** púrpura úmida e hemorragia retiniana. Adulto: sorologia HIV e HCV; Coombs se anemia (Evans).

Situação	Conduta
Criança sem sangramento ou só cutâneo	**Observação**, sem remédio
Mucosa sem risco de morte	Prednisona 2–4 mg/kg/dia 5–7 dias, ou dexametasona, ou **IgIV** 0,8–1 g/kg, ou anti-D
Emergência (HIC)	**Plaquetas** + metilprednisolona 30 mg/kg + IgIV
Adulto	> 30.000 não aumenta mortalidade · prednisona 1 mg/kg ou anti-D · 2ª linha: agonista de TPO, rituximabe, esplenectomia

3 Von Willebrand e hemofilias

Doença de von Willebrand

Hereditária **mais comum**, autossômica (homens e mulheres). Tipo **1** (≥ 80%) quantitativo · **2B** plaquetopenia, **desmopressina contraindicada** · **2N** simula hemofilia A · **3** ausência, hemartroses. Mucocutâneo e **menorragia**. FvW:RCo/FvW:Ag ≥ 0,7 = tipo 1; < 0,7 = tipo 2. **Desmopressina 0,3 µg/kg** no tipo 1; concentrado FVIII/FvW; antifibrinolítico.

Hemofilias A (FVIII) e B (FIX)

Ligadas ao X · 30% sem história familiar. Grave **< 1%** · moderada 1–5% · leve 5–40% (MS). Hemartrose (70–80%). TTPa longo que corrige; TP e plaquetas normais. **FVIII = (alvo − basal) × peso × 0,5** · FIX × 1. Meia-vida FVIII 8–12 h, FIX 24 h. TCE: 80–100% já, antes da TC. **Profilaxia** é o padrão na criança grave.

Inibidor (~30% na hemofilia A grave): Bethesda < 5 UB → dobrar a dose · ≥ 5 UB → **agente de bypass** (CCPa ou FVIIa) · imunotolerância · **emicizumabe** no SUS (com inibidor; sem inibidor até 6 anos).

4 TEV e antitrombóticos

Virchow: estase, hipercoagulabilidade, lesão endotelial. Probabilidade baixa/moderada → **D-dímero** (só exclui); alta → imagem. TVP: **US com compressão**. EP: **angiotomografia**. EP maciça: **alteplase 100 mg em 2 h**. Anticoagular ≥ 3 meses.

HNF: TTPa · protamina. **HBPM:** anti-Xa · protamina parcial. **Varfarina:** INR 2–3 · vit. K + complexo protrombínico. **Anti-Xa:** andexanet. **Dabigatrana:** idarucizumabe. **TIH** 5–10 dias → argatrobana ou fondaparinux.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Hemofílico forma o tampão:** ele só não se sustenta; sangra horas depois.
2. **Petéquias = plaqueta**; hemartrose = fator.
3. **TP isolado longo** no início da varfarina: FVII tem a menor meia-vida.
4. **FXII baixo** alonga muito o TTPa e não sangra.
5. **PTI ≠ dengue:** na PTI não há febre no sangramento; na dengue há leucopenia e hematócrito subindo.
6. **Plaquetas muito baixas sangram pouco** na PTI: são jovens e funcionais.
7. **Anticorpo antiplaquetário** não é de rotina na PTI.
8. **Leucemia** raramente vem com plaquetopenia isolada; dor óssea e visceromegalia pedem mielograma.
9. **Anti-D** só em Rh+, com baço e Coombs negativo.
10. **Desmopressina** não funciona na hemofilia A grave nem na B, e é proibida no DvW 2B.
11. **Grupo O** tem metade do FvW: exame normal não exclui DvW.
12. **Mulher portadora** de hemofilia pode sangrar (fator de 22% a 116%).
13. **Nunca AAS, AINE ou IM** em quem tem coagulopatia.
14. **Ácido tranexâmico** não se usa na hematúria (coágulos).

Números que caem

FVIII (UI) = (alvo − basal) × peso × 0,5 · ex.: 70 kg, 0 → 100% = **3.500 UI**
FIX (UI) = (alvo − basal) × peso × 1
Plaquetas 150–450 mil · **fibrinogênio** mínimo 100 mg/dL · **INR** 2–3